当院における子宮内膜細胞診で ATEC-A と判定した症例の後方視的検討

◎村瀬 華[1)]、川島 佳晃[1)]、中嶋 綾香[1)]、岡部 麻子[2)]、浦野 誠[2)]
藤田医科大学ばんたね病院 病理部[1)]、藤田医科大学ばんたね病院 病理診断科[2)]

【はじめに】
子宮内膜細胞診の判定は、従来より 3 段階分類(陰性・疑陽性・陽性)が広く使用されているが、当院では 2020 年 11 月から記述式内膜細胞診報告様式を導入した。今回、細胞診で Atypical endometrial cells, cannot exclude atypical endometrial hyperplasia or more (3 段階分類で疑陽性相当、以下 ATEC-A)と判定した症例に関して後方視的に検討し、診断精度の評価を行った。

【対象】
2020 年 11 月から 2025 年 12 月までに ATEC-A と判定した症例のうち、組織診で確定診断されている 35 症例を対象とした。

【方法】
細胞診で ATEC-A と判定した後に実施された組織診断(生検・手術)を抽出した。また、ATEC-A と判定した症例を細胞検査士 3 名で再鏡検し、判定の妥当性について検討した。

【結果】
ATEC-A と判定した症例の組織診断は良性 19 例(54.3%)、良悪性境界病変 4 例(11.4%)、悪性 12 例(34.3%)であった。良性症例の内訳は正常内膜が 16 例、子宮内膜腺間質破綻が 1 例、子宮留膿腫が 1 例、不規則増殖内膜が 1 例であった。良悪性境界病変症例の内訳は子宮内膜異型増殖症が 4 例であった。悪性の内訳は類内膜癌 11 例、子宮頸部扁平上皮癌の浸潤が 1 例であった。
また、再鏡検をした結果、3 例が Atypical endometrial cells, of undetermined significance （3 段階分類で疑陽性相当、ATEC-US)、3 例が悪性相当と考えられた。

【考察】
ATEC-A は子宮内膜異型増殖症以上を除外できない場合に用いる判定である。当院では ATEC-A と判定した症例の 45.7%がその後の組織診で良悪性境界病変以上であった。組織診が良性であった症例を ATEC-A と判定した要因としては、炎症、薬物治療、ホルモン環境異常に伴う化生性変化などの細胞を過剰判定していたことが考えられる。今後も継続的に細胞診と組織診の結果を比較検討し、診断精度向上に努めていきたい。

連絡先:052-323-5665